

Pancreatitis aguda y crónica

1. Introducción y relevancia clínica

La **pancreatitis** es una enfermedad inflamatoria del páncreas que puede manifestarse de manera **aguda o crónica**, dependiendo de la extensión y duración del daño.

La **pancreatitis aguda (PA)** corresponde a un proceso inflamatorio reversible del parénquima pancreático que puede comprometer órganos vecinos o incluso producir falla multiorgánica.

La **pancreatitis crónica (PC)**, en cambio, es una inflamación persistente e irreversible, con fibrosis progresiva y pérdida funcional del páncreas exocrino y endocrino.

La pancreatitis aguda es una **urgencia médica frecuente** en servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos.

En Chile, las principales causas son la **litiasis biliar** (50–60%) y el **consumo de alcohol** (20–30%).

La mortalidad global es baja (<5%), pero puede alcanzar el 30% en casos graves con necrosis o falla orgánica.

En el **EUNACOM**, este tema es clásico y evaluado por su frecuencia, su manejo inicial en urgencias y la necesidad de diferenciar causas biliares, alcohólicas y metabólicas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Pancreatitis aguda

La pancreatitis aguda se origina por **activación intrapancreática prematura de las enzimas digestivas**, especialmente la tripsina, que desencadena **autodigestión del tejido pancreático**, inflamación local y respuesta sistémica.

Los principales mecanismos incluyen:

- **Obstrucción del conducto pancreático** (cálculo biliar o espasmo del esfínter de Oddi).
- **Daño tóxico directo** (alcohol, fármacos).
- **Reflujo duodenal o biliar** hacia el páncreas.
- **Aumento de presión ductal o permeabilidad vascular.**

El proceso genera **necrosis grasa, inflamación intersticial y liberación de mediadores inflamatorios** (IL-1, IL-6, TNF- α), responsables del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y de la falla multiorgánica.

2.2. Pancreatitis crónica

Se produce por **episodios repetidos de inflamación aguda** que llevan a **fibrosis progresiva, pérdida de acinos y alteración de los conductos pancreáticos**.

El alcohol es la causa más frecuente ($\approx 70\%$ de los casos), seguido de hipertrigliceridemia, factores genéticos, obstrucciones ductales y causas autoinmunes.

El daño crónico conlleva a:

- **Insuficiencia exocrina:** mala digestión, esteatorrea, pérdida de peso.
 - **Insuficiencia endocrina:** diabetes mellitus pancreatogénica (tipo 3c).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Pancreatitis aguda

Síntomas principales:

- **Dolor abdominal intenso** en epigastrio o hipocondrio izquierdo, de inicio súbito, irradiado en “cinturón” hacia la espalda.
- **Náuseas y vómitos intensos.**
- **Distensión abdominal y fiebre.**

Signos clínicos:

- Dolor a la palpación epigástrica.
- Hipersensibilidad abdominal sin defensa marcada (en formas leves).
- En casos graves: taquicardia, hipotensión, fiebre, taquipnea.
- Signos de hemorragia retroperitoneal (poco frecuentes):

- **Signo de Cullen:** equimosis periumbilical.
- **Signo de Grey Turner:** equimosis en flancos.

Evolución clínica:

- Formas leves: resolución en 3–5 días.
 - Formas graves: necrosis, colecciones, sepsis o falla multiorgánica.
-

3.2. Pancreatitis crónica

Síntomas principales:

- Dolor epigástrico crónico, persistente o recurrente, irradiado a dorso.
 - Empeora con comidas y alcohol.
 - Esteatorrea (heces voluminosas, grasosas, malolientes).
 - Baja de peso progresiva.
 - En etapas tardías: diabetes mellitus secundaria.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

- Colecistitis aguda.
 - Úlcera péptica perforada.
 - Isquemia mesentérica.
 - Obstrucción intestinal.
 - Infarto agudo al miocardio inferior.
 - Aneurisma aórtico roto.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico de pancreatitis aguda

Se establece con **al menos 2 de los siguientes 3 criterios (Atlanta, 2012)**:

1. Dolor abdominal típico.
2. Elevación de amilasa o lipasa ≥ 3 veces el valor normal.
3. Hallazgos característicos en imágenes (TC, RM, ecografía).

4.2. Laboratorio

- **Amilasa y lipasa séricas:** aumentan a las 6–12 h y se normalizan en 3–7 días.
 - La **lipasa** es más sensible y específica.
- **Leucocitosis** y aumento de PCR o procalcitonina.
- **Calcio sérico:** disminuido en pancreatitis grave.
- **Triglicéridos:** si >1000 mg/dL $\rightarrow$ causa metabólica.
- **Transaminasas elevadas:** sugieren etiología biliar.

4.3. Imágenes

- **Ecografía abdominal:** evalúa litiasis biliar y dilatación de vías biliares.
- **TC abdominal con contraste (a las 72 h):** determina gravedad, necrosis o complicaciones locales.
- **Colangioresonancia o CPRE:** se reservan para casos con obstrucción biliar persistente.

4.4. Evaluación de gravedad

- **Criterios de Atlanta (2012):**
 - **Leve:** sin falla orgánica ni complicaciones.

- **Moderada:** falla orgánica transitoria o complicaciones locales.
 - **Grave:** falla orgánica persistente (>48 h).
 - **Escalas pronósticas:** Ranson, APACHE II, BISAP (útiles al ingreso y 48 h).
-

5. Tratamiento de pancreatitis aguda

5.1. Medidas generales

- **Hospitalización** en unidad de cuidados intermedios o intensivos.
- **Ayuno absoluto** (reposo pancreático).
- **Hidratación vigorosa con cristaloideos:** Ringer lactato 250–500 mL/h, ajustando según respuesta.
- **Analgesia:** opioides (morfina, buprenorfina o tramadol).
- **Oxigenoterapia si hipoxemia.**
- **Antibióticos:** solo si hay necrosis infectada o colangitis.

5.2. Nutrición

- En pancreatitis leve: reiniciar dieta oral a las 48–72 h si el dolor cede.
- En pancreatitis grave: **nutrición enteral por sonda nasoyeyunal**, preferida sobre la parenteral (reduce infecciones).

5.3. Manejo de la causa

Pancreatitis biliar:

- Realizar **colangiografía o CPRE** si hay colangitis o ictericia obstructiva.
- **Colecistectomía** durante la hospitalización (idealmente dentro de la misma estadía).

Pancreatitis alcohólica:

- Abstinencia absoluta de alcohol.

- Apoyo nutricional y vitamina B1 (tiamina).

Hipertrigliceridemia:

- Fibratos, insulina o plasmaféresis en casos severos.
-

5.4. Complicaciones y manejo

- **Necrosis pancreática infectada:** sospechar si fiebre o deterioro tras 5–7 días.
 - Confirmar con TC y cultivo por punción.
 - Manejo: antibióticos (carbapenémicos) y drenaje percutáneo o quirúrgico.
 - **Pseudoquistes pancreáticos:** colecciones encapsuladas >4 semanas; drenaje si >6 cm o sintomáticos.
 - **Absceso pancreático:** drenaje + antibióticos.
 - **Falla multiorgánica:** soporte vital (respiratorio, renal, cardiovascular).
-

6. Pancreatitis crónica

6.1. Diagnóstico

Se basa en clínica, imágenes y alteración funcional:

- **TC o RM pancreática:** calcificaciones, dilatación ductal, atrofia.
- **Pruebas de función pancreática:** elastasa fecal disminuida.
- **Diabetes o malabsorción:** evidencia funcional tardía.

6.2. Tratamiento

Medidas generales:

- Abstinencia total de alcohol y tabaco.

- Dieta hipocalórica fraccionada.
- Analgesia escalonada.
- Control de glucemia.

Tratamiento específico:

- **Enzimas pancreáticas orales** (lipasa 25.000–40.000 U con comidas) para tratar esteatorrea.
 - **IBP o ranitidina** para mejorar pH gástrico y eficacia enzimática.
 - **Vitamina liposolubles (A, D, E, K)** en caso de malabsorción.
 - **Cirugía o drenaje endoscópico** si obstrucción ductal o dolor refractario.
-

7. Complicaciones

Pancreatitis aguda:

- Shock hipovolémico.
- Necrosis y abscesos pancreáticos.
- Fístulas pancreáticas.
- Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).
- Falla multiorgánica.

Pancreatitis crónica:

- Esteatorrea y desnutrición.
 - Diabetes pancreatogénica.
 - Pseudoquistes y obstrucción biliar.
 - Riesgo aumentado de cáncer de páncreas.
-

8. Pronóstico

- **Pancreatitis aguda leve:** recuperación completa en >90 %.
- **Grave:** mortalidad hasta 30 % (si necrosis infectada o falla orgánica).
- **Crónica:** curso progresivo con deterioro funcional irreversible.

El pronóstico mejora con diagnóstico precoz, hidratación adecuada y tratamiento etiológico.

9. Prevención

1. Evitar consumo de alcohol y tabaco.
 2. Controlar dislipidemias e hipertrigliceridemia.
 3. Colecistectomía en litiasis biliar.
 4. Precaución con fármacos pancreatotóxicos (azatioprina, valproato, tiazidas).
 5. Educación nutricional en pacientes con episodios previos.
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El diagnóstico de pancreatitis aguda se confirma con **dolor típico + amilasa/lipasa ≥ 3 veces normal**.
2. La **etiología más frecuente** en Chile es la litiasis biliar, seguida del alcohol.
3. La **TC con contraste a las 72 h** evalúa complicaciones y gravedad.
4. **Hidratación precoz** con Ringer lactato reduce complicaciones.
5. **Nutrición enteral** es preferida a la parenteral.
6. En pancreatitis biliar, realizar **colecistectomía en la misma hospitalización**.
7. En pancreatitis crónica, tratar la **insuficiencia exocrina** con enzimas pancreáticas.

Errores comunes:

- Indicar antibióticos en todas las pancreatitis.
 - Retrasar hidratación o subestimar gravedad.
 - No buscar causa biliar o metabólica.
 - Omitir manejo nutricional o de dolor en crónicas.
 - Usar parenteral innecesaria en casos leves.
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **pancreatitis aguda** es inflamación reversible del páncreas, causada principalmente por cálculos biliares y alcohol.
2. Se diagnostica con **dolor típico, elevación enzimática y/o hallazgos en imágenes**.
3. El tratamiento es **soporte intensivo**: hidratación, analgesia y reposo pancreático.
4. La **TC con contraste** evalúa necrosis y complicaciones.
5. La **pancreatitis crónica** cursa con dolor persistente, esteatorrea y diabetes.
6. El manejo incluye **abstinencia de alcohol, enzimas pancreáticas y control del dolor**.
7. En casos biliares, realizar **colecistectomía durante la hospitalización**.